جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : سهير فرحات احمد محمد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** البدرشين **العنوان :** العزيزه
رقم البطاقة : 27811192102189 **رقم التليفون :** 01144599960 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 19-11-1978 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سهير فرحات احمد محمد
National ID: 27811192102189

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bone scintigraphy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Sohair Farahat Ahmed Mohamed	Date : 27/01/2025
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 578/2023	Pat. ID: 29025

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. Chest:

As compared to prior study dated 23/2/2023, The current revealed:

- Rather stationary course regarding :
  - Left breast UIQ irregular speculated mass lesion measuring 1.5 x 1.7 cm.
  - Left axillary level I few lymph nodes the largest measures 1 x 1.1 cm.
- No sizable pulmonary nodules, masses or consolidations.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

As compared to prior study dated 22/3/2023, The current revealed:

- The liver is still seen enlarged with homogenous CT texture. Segment VIII still shows rather unchanged rather two defined hypodense focal lesions the largest still measuring about 2.2 x 2.5 cm.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Left renal upper calyceal dense stone is still noted *Otherwise*, Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no right renal stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name: سهير فرحات احمد محمد	
MR. : 5528	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

MBC TO BONE 2/2/2026: EF 67% 4/2/2026: C 20 HERCEPTIN +ZOMETA

prem left breast cancer met to bone er3/8 pr3/8 her23+ initial pet ct multiple osseous lesions non fdg avid hfl rec taxol herceptin then kept on maintenance herceptin from 3/25025 for c21 herceptin ef 2/2/2026 67% for new cts

prem left breast cancer met to bone er3/8 pr3/8 her23+ initial pet ct multiple osseous lesions non fdg avid hfl rec taxol herceptin then kept on maintenance herceptin from 3/2025 c22 herceptin ef 2/2/2026 67% PENDING CT CAP TVUS 25/2/2026 BULKY UTRUS 10*5/4 CM THE MYOYOMETRIUM SHOWS MULTIPLE INTRAMURAL SUBSEROUS FIBROIDS LARGEST INTRAMURAL ONE IS SEEN AT ANT WALL 20*20 MM FIGO 4 LARGEST FIBROIDS ARISING FROM ANT WALL MEASURING 16*15 MM ENDOMETRIAL LINE 5 MM IUD IN PLACE FSH 176 E2 10 PT COMPLAINED FROM RECURRENT MASSIVE VAGINAL BLEEDING FOR SURGICAL CONSLTATION

CT CAP 11/2026 >> REGRESSIVE COURSE REGARDING SIZE OF BREAST MASS , STATIONARY REGARDING REST OF STUDY TODAY : C23 HERCEPTIN IV C 24 , C 25 >> HERCEPTIN IV PHARMACY + NEW ECHO

CT CAp 3-6-2026 >> HFL 2.2*2.5 cm (stationary in size from the start) regression of breast mass 13mm*6mm Vs 11*12 mm SD of rest study PAUS >> no comment on HFL >> referred to repeat PAUS bone scan 26-6-2026 >> free from mets hereptin approval still pending

herceptin pending approval for zometa labs accepted done outside

for herceptin iv c25, echo 65% EF 19/8 Pt still complaining of recurrent vaginal bleeding, for TVUS to assess need to hystercetomy vs conservative management

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

PATIENT [redacted] PAID/009359

Date: 20/08/2024

Ref.Prof.Doc: [redacted]

Pat. Age 45 Year(s)

^{18}F-FDG PET/CT examination

Clinical history: A patient with history of left breast cancer is referred for assessment.

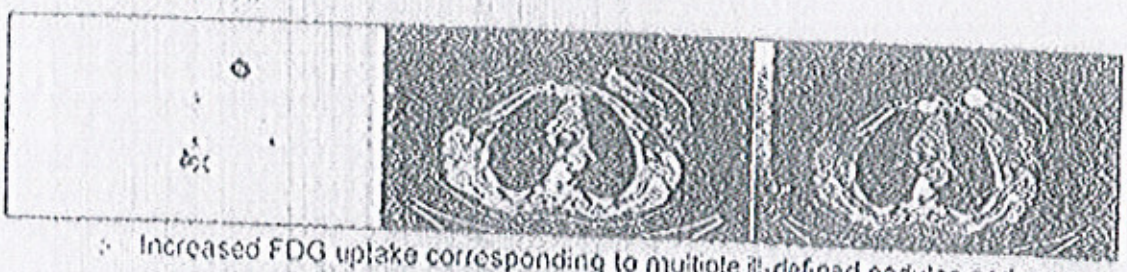
Dose: was given according to patient's body weight.

Procedure:

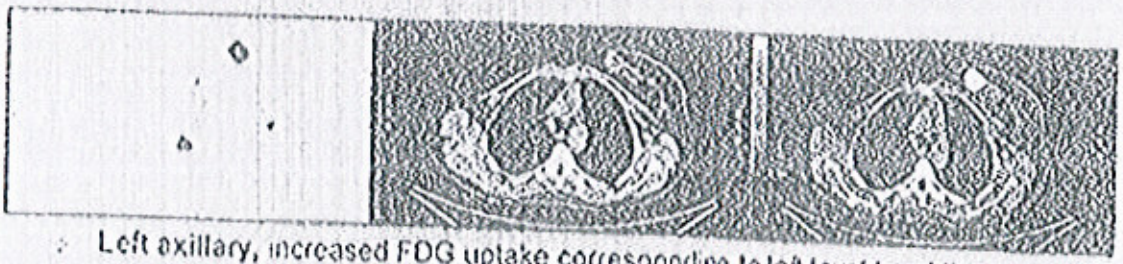
- Prior to administration of the radiotracer, blood glucose level was 104 mg/dl.
- CT images for attenuation and localization followed by PET images from the skull vertex to mid-thigh were obtained.

Findings:

- Left breast:



- Increased FDG uptake corresponding to multiple ill-defined nodules and masses with spiculated outline seen within upper inner, upper outer and lower outer quadrants, the largest lesion seen in the upper outer quadrant with SUVmax 6 and measures 5.1 x 3.5 cm, another upper inner quadrant lesion with SUVmax 7.4 as measured over a 2.4 x 2 cm
- Right breast: no FDG avid lesions
- Lymph nodes:



- Left axillary, increased FDG uptake corresponding to left level I and II nodes. SUVmax 3.3 as measured over a 1.4 cm level I node
- No significant FDG uptake within small right axillary level I nodes.
- Low grade FDG uptake by small bilateral cervical lymph nodes, *likely nonspecific.*

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Patient Name	: الأسكندرية / سهير فرحات احمد محمد	Request No.	: 13005255
Patient No.	: 27811192102189	Request Date	: 18/01/2023
Path No.	: 157/23	Verification Date	: 18/02/2023
Sex	: Female	Financial Category	: دراسات عليا - مبادرة
Age	: 44 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed yousif

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Tru cut biopsy, collected at 17/1/2023, 1:45 pm.

Gross Examination:
- Three greyish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for Immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II
- DCIS: Focal low grade.
- Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved.
- IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8).
- PR: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67: 20% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Left breast lesion, Tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II.
IPT:
- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- Her2: Positive (score 3+).
- Ki67: Positive in 20% of tumor cells.

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]